Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Três Lagoas
Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos

Autos 0800652-47.2019.8.12.0021
Parte Autora: Jair Lúcio da Silva
Parte Requerida: Estado de Mato Grosso do Sul

Vistos, etc.

Jair Lúcio da Silva, qualificado nos autos, ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso do Sul, também qualificado nos autos, alegando, em suma, que tem 46 anos de idade e desenvolveu insuficiência venosa crônica (CID I.87.2) após a realização de procedimento cirúrgico em 2013, que deixou sequelas na mobilidade do membro inferior direito; relata que a patologia apresentada possui como característica a umidade, o que acarreta a necessidade de trocar diversas vezes curativos durante o dia, além disso, a ferida apresenta odor fétido com risco de evolução de infecção para amputação e óbito; afirma que submeteu-se a diversos tratamentos sem sucesso; relata que a lesão vem prejudicando a sua capacidade laborativa e convívio social; o médico que o acompanha prescreveu o uso de diversos medicamentos, tendo em vista que o tratamento padrão oferecido pelo SUS e até então utilizado, qual seja, gaze simples e solução fisiológica, mostrou-se ineficaz; esclarece que o relatório médico foi elaborado após consulta à lista RENAME, não sendo encontrado nenhum insumo ou medicamento que atenda às suas necessidades; assevera que não possui condições financeiras para arcar com os custos do tratamento.

Requer a condenação do Requerido na obrigação de fazer consistente no fornecimento de a) gaze comum 50 pacotes, b) solução fisiológica 500ml, c) os curativos: Pielsana Polihexanida solução e gel, Cutimed Siltec Sorbact, Dermamon, Cuticell Contact, Vuelo Spray Barreira, d) Compri 2 Lite e) Jobst for men. Atribuiu valor à causa, juntou documentos e pediu a gratuidade de justiça.

Pelo despacho de fl. 65, foi determinada a remessa do feito ao NAT, que se manifestou desfavorável quanto ao fornecimento de Pielsana Polihexanida solução e gel, Cutimed Siltec Sorbact, Dermamon, Cuticell Contact, Vuelo Spray Barreira, Compri 2 Lite e Jobst for men e favorável ao pedido de gaze comum e solução fisiológica, conforme parecer juntado às fls. 74/83.

O Estado de Mato Grosso do Sul manifestou-se, às fls. 87/88, pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência.

Emenda à inicial às fls. 91/93.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 29/05/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800652-47.2019.8.12.0021 e código MK86GgJS.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Três Lagoas
Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos

Pela decisão de fls. 94/101 foi retificado de ofício o valor da causa para R$ 111.099,48, considerando a duração estimada de 06 (seis) meses de tratamento do Autor, conforme relatório médico de fls. 39/40, e acolhido o pedido de tutela de urgência para fornecimento dos curativos Pielsana Polihexanida solução e gel, Cutimed Siltec Sorbact, Dermamon, Cuticell Contact, Vuelo Spray Barreira; Compri 2 Lite; e Jobst for men.

Citado, o Estado de Mato Grosso do Sul contestou às fls. 111/120, requerendo, preliminarmente, o chamamento ao processo do Município de Selvíria, por ser solidária a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento ao Autor; sustenta, ainda, em sede preliminar, falta de interesse processual, pois gaze comum e solução fisiológica seriam suficientes para o tratamento e são fornecidas pelo SUS. No mérito, requer a observância do julgamento proferido pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ, que impôs o preenchimento de requisitos cumulativos para o paciente obter a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS; que não há provas da imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados, tampouco da ineficácia daqueles fornecidos pelo SUS; que o SUS oferece tratamento alternativo à mazela que acomete o Autor. Pugnou pela improcedência.

Impugnação à contestação às fls.123/130.

Às fls. 131/133, o Autor informou que o Estado não cumpriu a decisão antecipatória da tutela, requerendo o bloqueio da quantia de R$ 55.549,74, conforme orçamento de menor valor juntado aos autos (fls. 72/73).

É o relatório. Decido.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o feito comporta julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não há necessidade de produção de outras provas além das constantes dos autos.

O Autor sofre de insuficiência venosa crônica (CID I.87.2) e possui grande ferida aberta na perna direita, decorrente de procedimento cirúrgico realizado em 2013, e que demora a cicatrizar, comprovando não ter condições econômicas para arcar com o custo do tratamento prescrito por médico especialista em cirurgia vascular.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 29/05/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800652-47.2019.8.12.0021 e código MK86GgJS.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Três Lagoas
Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos

O Requerente requer a disponibilização de a) gaze comum 50 pacotes, b) solução fisiológica 500ml, c) os curativos: Pielsana Polihexanida solução e gel, Cutimed Siltec Sorbact, Dermamon, Cuticell Contact, Vuelo Spray Barreira, d) Compri 2 Lite e) Jobst for men (fls. 36/38), pois, segundo o relatório médico de fls. 39/40, não foram encontrados na lista RENAME produtos ou medicamentos para lesões de pele que atendam às indicações clínicas do caso.

Havendo preliminares arguidas pelo Estado de Mato Grosso do Sul, passa-se ao exame.

O Estado requer o chamamento ao processo do Município de Selvíria/MS.

Não lhe assiste razão.

Todos entes públicos estão arrolados no texto constitucional como legitimados a garantir e efetivar o direito fundamental à saúde. Com efeito, não há norma na Constituição Federal de 1988 que delimite o âmbito de atuação dos Municípios a tratamentos de baixo custo ou de pouca complexidade, por exemplo, ou que o Estado fique circunscrito a determinado campo de atuação.

De fato, o artigo 23, inc. II, da Constituição Federal define a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para cuidar da saúde e assistência pública, proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Veja-se:

> Art. 23. É competência comum da União, dos Estado, do Distrito Federal e dos Municípios:
> (...)
> II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Somado a isso, a Constituição Federal, em seu artigo 196 prevê que:

> Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O termo "Estado" previsto na norma acima deve ser entendido em

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 29/05/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800652-47.2019.8.12.0021 e código MK86GgJS.

sua acepção ampla, de modo a englobar todos os entes federativos, ou seja, a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios.

Os artigos 2º e 4º, da Lei n.º 8.080/90, que disciplina as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, estabelecem:

> Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
> (...)
> Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). (destaquei)

Dispõe o § 1º do artigo 198 da Constituição Federal:

> O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estado, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Logo, percebe-se que todos os entes possuem legitimidade para figurarem no polo passivo das ações em que seja pleiteado providências relacionadas ao direito fundamental à saúde, de modo que deve ser rejeitado o pedido de inclusão do Município de Selvíria no polo passivo da lide.

A propósito, é firme a Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul nesse sentido:

> E M E N T A-APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE CIRURGIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - PRELIMINAR REJEITADA - REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA - PRESENÇA - VEROSSIMILHANÇA E COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO IMEDIATO ATENDIMENTO - TRATAMENTO A SER ARCADO PELO RECORRENTE - PREVISÃO CONSTITUCIONAL - NÃO PROVIDO. O Sistema Único de Saúde - SUS é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos federais, estaduais e municipais, a teor do que dispõe o art. 4º, caput, da Lei Federal n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Logo, independentemente do convênio celebrado, a responsabilidade do Município de Naviraí e do Estado de Mato Grosso do Sul na prestação dos serviços de saúde, é concorrente com a União. Deste modo, a recusa do Município de figurar no pólo passivo desta ação, sob a alegação da política de descentralização, onde cada qual procura eximir-se de sua responsabilidade, não prospera. (...)
> *(TJMS - 0802623-53.2013.8.12.0029 – Apelação - 2ª Câmara Cível - Des. Marcos José*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 29/05/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800652-47.2019.8.12.0021 e código MK86GgJS.

de Brito Rodrigues – j. em 16/12/2014)

E M E N T A – AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO – RESPEITO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DA RESPECTIVA CORTE DE JUSTIÇA E DO STJ – AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA – MEDICAMENTO – MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA CONFIRMADA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASIVA DO MUNICÍPIO – AFASTADAS – MÉRITO – DIREITO À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (...) Existe solidariedade na assistência à saúde entre a União, o Estado e o Município, podendo a ação ser ajuizada em face de todos, de alguns ou de apenas um, por essa razão, não há falar em ilegitimidade do Estado e do Município para figurarem no pólo passivo da ação. A Constituição Federal, em seu artigo 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados tratamento adequado e eficaz, capaz de ofertar a quem necessite maior dignidade e menor sofrimento.
(TJMS - Agravo Regimental -Nº 080170-42.2013.8.12.024/500 - Aparecida do Taboado - 4ª Câmara Cível – Rel. Des. Claudionor Miguel Abs Duarte – j. em 29 de julho de 2014) (destaquei)

E M E N T A–AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CONCESSÃO DE MEDICAMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA, À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DEVER DO ESTADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são partes legítimas para figurar no polo passivo nas demandas cuja pretensão é o fornecimento de medicamentos e procedimentos médicos, imprescindíveis à saúde de pesoa carente, não existindo nenhuma hierarquia entre estes na área da saúde, razão pela qual não pode o Estado esquivar-se de seu dever.
(TJMS - Agravo de Instrumento -Nº 141043-51.2014.8.12.00 – Naviraí - 3ª Câmara Cível – Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho – j. em 16 de dezembro de 2014) (destaquei)

Portanto, há solidariedade entre os Municípios, Estados, União e Distrito Federal no que se refere ao dever de fornecer a todos o tratamento de saúde necessário para manutenção da vida com dignidade, por meio do Sistema Único de Saúde, de modo que cabe a qualquer deles isoladamente ou em litisconsórcio, a critério da parte autora, figurar no polo passivo.

Portanto, cabendo à parte escolher em face de quem proporá a ação, podendo, inclusive, acionar o Estado isoladamente, não se pode acolher o pleito liminar de chamamento do ente municipal.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 29/05/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800652-47.2019.8.12.0021 e código MK86GgJS.

Ademais, sustenta o Estado de Mato Grosso do Sul a ausência de interesse de agir, ao argumento que os insumos gaze comum e soro fisiológico seriam suficientes para o tratamento do Autor e por serem disponibilizados nas Unidades Básicas de Saúde não haveria necessidade de ajuizar a presente demanda.

Contudo, a preliminar deve ser afastada, isso porque o relatório e prescrição médicos de fls. 36/40 deixam patente a insuficiência da utilização de gaze e soro fisiológico para tratamento da anomalia que acomete o paciente, de modo que necessita dos demais medicamentos e curativos para combater a grave lesão venosa que acomete a sua saúde e prevenir a progressão do caso.

Além disso, observa-se que a eventual ausência dos insumos pleiteados na lista fornecida pelo SUS não é fato impeditivo do fornecimento pelo Poder Público, notadamente, quando demonstrada a sua vital necessidade.

Com efeito, a gravidade da lesão que aflige a parte autora é evidente, devidamente atestada pelos documentos que instruem o caderno processual, especialmente pelo relatório médico de fls. 39/40.

Assim, sendo o interesse processual evidente, torna-se necessária a manifestação do órgão jurisdicional competente para por fim à demanda instaurada, até porque se trata de direito fundamental à vida e saúde.

Nessa direção são os ensinamentos de Rodrigo da Cunha Lima Freire:

> O interesse de agir é resultado da necessidade da tutela jurisdicional, tendo em vista a indispensabilidade da jurisdição para recompor um direito lesado, bem como evitar ou reparar um dano injusto.
> *(Condições da Ação – Enfoque sobre o interesse de agir. 3ª ed. São Paulo: RT, 2005, p. 155)*

Dessa forma, fica afastada a preliminar de falta de interesse processual.

Analisadas e rechaçadas as preliminares, passa-se a examinar o mérito. Assim, do cotejo das alegações trazidas pelas partes, é possível concluir que o pedido inicial merece procedência, senão vejamos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 29/05/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800652-47.2019.8.12.0021 e código MK86GgJS.

Com efeito, o direito à saúde está inserido no rol dos direitos sociais constitucionalmente assegurados e efetivadores da dignidade humana. Trata-se de um direito público subjetivo, uma prerrogativa jurídica indisponível garantida à generalidade de pessoas.

O fundamento constitucional da garantia do direito à saúde encontra-se previsto no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, que traz arrolados os chamados direitos sociais, quais sejam:

> São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Assim, o artigo 196 da Constituição Federal impõe ao Estado a obrigação de prestar a assistência integral à coletividade no tocante à saúde, entendida como um direito de todos:

> A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação.

Conforme assentado por Hewerston Humenhuk :

> A saúde também é uma construção através de procedimentos. (...) A definição de saúde está vinculada diretamente a sua promoção e qualidade de vida. (...) O conceito de saúde é, também, uma questão de o cidadão ter direito a uma vida saudável, levando a construção de uma qualidade de vida, que deve objetivar a democracia, igualdade, respeito ecológico e o desenvolvimento tecnológico, tudo isso procurando livrar o homem de seus males e proporcionando-lhe benefícios.
> *(HUMENHUK, Hewerstton. O direito à saúde no Brasil e a teoria dos direitos fundamentais, 2010)*

Dessa forma, o acesso adequado e eficiente à saúde é bem jurídico constitucionalmente protegido, por cuja integridade deve zelar, de maneira responsável, o Poder Público atuante, incumbindo-lhe a formulação e implementação de políticas sociais e econômicas aptas a garantir à coletividade, o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar, objetivando a concretização do direito.

No caso em estudo, cristalino o direito do Autor em receber os

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 29/05/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800652-47.2019.8.12.0021 e código MK86GgJS.

insumos e medicamentos pleiteados na inicial, mesmo porque sua qualidade de vida resta prejudicada e o problema de saúde tende a piorar, notadamente pelo fato de há anos estar sendo submetido a tratamento convencional, com uso de gaze comum e soro fisiológico, sem diminuição significativa da lesão na perna direita que apresenta.

Modernamente, conforme argumenta o Estado de Mato Grosso do Sul, se apresenta para os casos de fornecimento de medicamentos o precedente de observância obrigatória REsp 1.657.156/RJ do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

> ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.
> 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.
> 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.
> 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.
> 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 29/05/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800652-47.2019.8.12.0021 e código MK86GgJS.

> sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.
> *(REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)* (destaquei)

Posteriormente, o Colegiado daquela Corte acolheu Embargos de Declaração do Estado do Rio de Janeiro e modificou um trecho do acórdão do recurso repetitivo, trocando a expressão "existência de registro na ANVISA" para "existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência".

O Relator do recurso, Min. Benedito Gonçalves, explicou que o esclarecimento em Embargos de Declaração se fazia necessário para evitar que o sistema público seja obrigado a fornecer medicamentos que, devidamente registrados, tenham sido indicados para utilizações *off label* (fora da bula) que não sejam reconhecidas pela ANVISA nem mesmo em caráter excepcional, concluindo-se, ainda, que o *"(...) uso dentro das especificações aprovadas pela agência reguladora é medida que visa proteger o usuário do sistema de saúde, pois estes medicamentos foram submetidos a estudos clínicos que comprovam a sua qualidade, a sua efetividade e a sua segurança" .*

Ao realizarmos o cotejo do presente caso com o precedente de observância obrigatória, conforme impõe o artigo 927, inc. III, do CPC, temos que a *"(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito"* restou demonstrada às fls. 27/35 e não foi impugnada pelo Requerido, restando incontroversa nos autos; a *"(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência"* foi comprovada pelo NAT, conforme descrição do uso de cada insumo às fls. 80/81; restando apenas a análise da *"(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS"*.

Nesse ponto, pela documentação acostada, nota-se que o relatório médico de fls. 39/40 emitido por médico especialista que acompanha o quadro de saúde do Requerente, não só esclarece a ausência de medicamentos na lista RENAME para tratamento da mazela, como também justifica a utilização de cada um dos insumos pleiteados na inicial.

Assim, a despeito de o parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT ter se manifestado desfavorável ao atendimento do pedido (fls. 74/83), informando que, exceto gaze e soro fisiológico, os demais medicamentos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 29/05/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800652-47.2019.8.12.0021 e código MK86GgJS.

requeridos não se encontram padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), verifica-se que os insumos requeridos foram prescritos por médico especialista em cirurgia vascular, Dr. Alex Kanomata (fls. 36/38), que, de maneira detalhada, atestou a imprescindibilidade de cada um deles, como também expôs que não existe nenhum produto similar que atenda às necessidades do paciente, justificando a ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS e sugerido pelo NAT às fl. 82. Afirmou ainda o profissional que *"(...) Paciente passou por acompanhamento com cirurgião vascular e já fez tentativas de curativos convencionais para o tratamento da úlcera, entretanto, deixou de apresentar resposta terapêutica. (...) – fl. 40".*

Neste aspecto, conforme já dito acima, resta evidente a necessidade dos medicamentos para o paciente diagnosticado com lesão venosa grave, que *"(...) Devido ao estado bastante avançado da lesão e das atuais condições de saúde deste paciente, ressalto a urgência e emergência no início do tratamento prescrito, <u>ante o risco iminente que existe da necessidade de se proceder à amputação do membro lesionado ou da decorrência do óbito por sepse.</u> (...) – fl. 40 (destaquei).*

Assim, em que pese o parecer do NAT tenha sido desfavorável, entendo que, no presente caso, a necessidade dos medicamentos restou provado para o tratamento do Requerente.

Não há dúvidas, portanto, que o Autor necessita do uso dos medicamentos para obter a cicatrização completa da lesão. Ademais, o que se observa no caso em espeque é uma notória desproporcionalidade entre os bens jurídicos colocados em exame, vale dizer, entre tutelar, de imediato, a vida e saúde do Autor e impedir um eventual e pouco provável prejuízo do Poder Público.

Com efeito, sopesando o interesse econômico e social, além das outras tantas obrigações e direitos a serem garantidos à população, e o direito subjetivo inalienável do direito à vida e saúde, deve-se privilegiar o respeito inafastável à vida e à saúde humana do paciente, causando indignação que o pedido não tenha sido deferido mediante simples requerimento administrativo, que precisou de uma ação judicial para valer-se do direito.

Por fim, salienta-se que os princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação da saúde dos cidadãos impõem ao Poder Público a obrigação de fornecer, prontamente, os meios necessários ao tratamento ao necessitado, sobretudo, em casos como o relatado nos autos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 29/05/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800652-47.2019.8.12.0021 e código MK86GgJS.

Dessa maneira, a procedência do pedido inaugural é medida que se impõe.

Isso posto, confirmando os efeitos da tutela antecipada, julgo procedente a presente demanda, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso do Sul a fornecer ao Autor os medicamentos e curativos Pielsana Polihexanida solução e gel; Cutimed Siltec Sorbact; Dermamon; Cuticell Contact; Vuelo Spray Barreira; Compri 2 Lite; Jobst for men; gaze comum; e solução fisiológica, condicionados à apresentação de receituário médico atualizado e periódico, de 03 (três) em 03 (três) meses, para ser comprovada a continuação da necessidade, especialmente da dosagem, e evitando-se o fornecimento por prazo indeterminado.

Outrossim, julgo extinto o presente feito, com base no artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Isento das custas, em atendimento ao princípio da causalidade, condeno o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários advocatícios ao Advogado do Autor. Assim, em que pese tenha sido atribuído à causa o valor de R$ 111.099,48, considerando a duração estimada de 06 (seis) meses de tratamento do Autor, conforme relatório médico de fls. 39/40, entendo que, por se tratar de direito constitucional à saúde, o presente feito possui proveito econômico inestimável, razão pela qual, por apreciação equitativa, e tendo em vista a baixa complexidade da demanda, fixo os honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma dos §§ 2º e 8º, do CPC. Tais honorários terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data e juros moratórios pelo índice aplicado à caderneta de poupança a partir do trânsito em julgado da sentença (artigo 85, § 16, do CPC).

Nos termos do inciso I do artigo 496 do Código de Processo Civil, determino que, decorrido o prazo de recurso voluntário, sejam os autos encaminhados ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, observadas as cautelas legais.

Acaso seja interposto recurso de Apelação, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1º, CPC).

Se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 29/05/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800652-47.2019.8.12.0021 e código MK86GgJS.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Três Lagoas
Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos

para apresentar contrarrazões (art. 1.010, § 2º, CPC).

Na sequência, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Por fim, informou o Autor às fls. 131/133 que o Requerido não cumpriu a decisão antecipatória da tutela de fls. 94/101, deixando de providenciar os medicamentos e curativos que necessita o Autor, apesar do prazo dilatado de 30 (trinta) dias que lhe foi concedido para tomar as medidas cabíveis.

Assim, zelando pelo bom emprego das verbas públicas, antes de determinar o bloqueio de valores, intime-se o Estado de Mato Grosso do Sul, via mandado, com fulcro no art. 5º, § 5º Lei n.º 11.419/061, para que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, comprove a disponibilização do tratamento concedido ao Autor pela decisão de fls. 94/101.

Não comprovada a entrega dos insumos no prazo estipulado, determino o bloqueio, via BacenJud, independentemente de nova conclusão, no valor de R$ 55.549,74 (fls. 72/73) na conta bancária do Estado de Mato Grosso do Sul, suficientes para aquisição na rede privada de saúde dos medicamentos e curativos necessários ao tratamento durante 03 (três) meses, conforme relatório médico de fls. 39/40. Para aquisição dos medicamentos e curativos a quantia deverá ser transferida para a conta bancária mencionada às fl. 132, cabendo ao Autor prestar contas nos autos acerca da compra.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.

Três Lagoas, 28 de maio de 2019.

Aline Beatriz de Oliveira Lacerda
Juíza de Direito
(assinado digitalmente)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE BEATRIZ DE OLIVEIRA LACERDA, liberado nos autos em 29/05/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800652-47.2019.8.12.0021 e código MK86GgJS.